

Valutazione questionari

Guida rapida per i colleghi – come scegliere, somministrare e calcolare i questionari clinici nella versione italiana validata

Indirizzo dell'app: <https://pollasonoio.github.io/questionari-valutazione/>

Si apre con **Google Chrome** da computer o tablet. Non serve installare nulla né creare un account.

1. A cosa serve

L'app calcola i punteggi di questionari clinici (disabilità, funzione, dolore, fattori psicosociali, ritorno allo sport, qualità di vita) seguendo le istruzioni della **versione italiana validata** di ciascuno strumento, e produce un referto in PDF con grafici, spiegazione dei risultati e riferimenti bibliografici. Il paziente compila un modulo PDF (al computer, sul tablet o su carta); il professionista carica il modulo nell'app e ottiene il referto.

Privacy: i moduli caricati vengono letti ed elaborati solo nel browser del proprio computer; nessun dato viene inviato a server o salvato online. Chiudendo la pagina tutto viene cancellato. Conservi i moduli compilati e i referti secondo le regole dello studio (cartella clinica), mai nel sito dell'app.

2. Come si usa, in quattro passi

Passo 1 – Scegliere il questionario. Nella sezione «Trova il questionario» si filtra per distretto (lombare, cervicale, spalla, ginocchio, anca e inguine...) e per cosa si vuole misurare. Scegliendo un distretto compaiono prima gli strumenti specifici, poi quelli generici. Ogni scheda indica tempo di compilazione, età del campione di validazione, licenza e fonte.

Trova il questionario

Filtri per distretto e per cosa misura; ogni scheda riporta tempo di compilazione, età del campione di validazione e licenza. Da qui si scarica il modulo vuoto o si inseriscono le risposte di un modulo su carta.

Cerca per nome, distretto o cosa misura...

Distretto:

generico lombare cervicale spalla arto superiore gomito polso e mano anca e inguine **ginocchio** arto inferiore caviglia e piede

tendine d'Achille

Cosa misura: **disabilità** funzione dolore sintomi psicosociale rischio sensibilizzazione centrale sport qualità di vita

☐ mostra anche gli strumenti non ancora attivi

17 strumenti

Specifici per il distretto scelto (8)

ACL-RSI

Scala ACL-RSI per la valutazione del ritorno allo sport dopo lesione del legamento crociato anteriore

ginocchio sport psicosociale

≈ 2 min · adulti dopo ricostruzione del LCA · libero (uso clinico)

Versione italiana: Thiebat G. et al., Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2021 (Tabella 1). doi:10.1007/s00167-021-06498-8

Scarica modulo Inserisci risposte

IKDC

Modulo di valutazione soggettiva del ginocchio IKDC 2000

ginocchio sintomi funzione sport

≈ 10 min · adulti operati di LCA (18-42 anni nel campione) · libero (uso clinico)

Versione italiana del modulo IKDC 2000 (ESSKA/AOSSM), validata da Padua R. et al., Arthroscopy 2004;20:819-23.

Scarica modulo Inserisci risposte

KOOS-I

Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, versione italiana (KOOS-I)

ginocchio sintomi dolore funzione sport

qualità di vita

≈ 10 min · ≥ 18 anni (validazione italiana) · libero (uso clinico)

Versione italiana: Monticone M. et al., Osteoarthritis Cartilage 2012;20(4):330-5 (appendice).

Scarica modulo Inserisci risposte

LEFS-I

Lower Extremity Functional Scale, versione italiana (LEFS-I)

arto inferiore anca e inguine ginocchio

WOMAC

WOMAC Osteoarthritis Index, versione italiana (formato Likert)

ginocchio dolore funzione sintomi

OSPRO-YF 10

OSPRO-YF, versione a 10 item

generico lombare cervicale spalla ginocchio

psicosociale rischio

Figura 1 – Catalogo filtrato per «ginocchio»: gli strumenti specifici compaiono per primi.

Passo 2 – Far compilare il modulo. Con «Scarica modulo» si ottiene il PDF vuoto, che il paziente può:

- compilare al computer o sul tablet (con Anteprima del Mac, Acrobat Reader o l'app File dell'iPad) e **salvare con un nome nuovo**, per esempio *KOOS-I_Cognome_data.pdf*; se Anteprima segnala che il file è protetto, scegliere «Duplica»;
- stampare e compilare a penna: in questo caso le risposte si inseriscono nell'app con «Inserisci risposte» (circa 1 minuto).

In ogni item va segnata **una sola risposta**, salvo dove il modulo chiede esplicitamente più scelte.

Passo 3 – Caricare il modulo. Si trascinano i PDF compilati nel riquadro «Carichi i moduli compilati» (si possono caricare più questionari dello stesso paziente insieme). Se qualcosa non va, l'app lo segnala: risposte mancanti, due caselle spuntate nello stesso item, PDF senza campi compilabili. Con «Correggi risposte» si sistema a mano.

1. Carichi i moduli compilati

Trascini qui i PDF compilati oppure faccia clic per sceglierli

Moduli generati per questa app, compilati al computer o sul tablet. Si possono caricare più questionari dello stesso paziente.

Oppure inserisca le risposte a mano (moduli su carta)

ÖMPQ-21 — Questionario Örebro sul dolore muscoloscheletrico (ÖMPQ-21) ▼

Inserisci risposte

Figura 2 – Caricamento dei PDF compilati o inserimento manuale delle risposte dei moduli su carta.

Passo 4 – Leggere il risultato e scaricare il referto. Per ogni questionario compaiono i punteggi con una barra grafica (posizione nel range, con il significato dei valori bassi e alti), la spiegazione «Come leggere il risultato», l'errore di misura (SEM, MDC/SDC, MIC quando disponibili) e le risposte item per item. «Anteprima referto» mostra il PDF; «Scarica referto PDF» lo salva. Il referto riporta: dati del paziente, risposte date, risultati con grafici e, in fondo alla pagina, i riferimenti bibliografici.

Scala ACL-RSI per la valutazione del ritorno allo sport dopo lesione del legamento crociato anteriore [1]

PDF: ACL-RSI_Paziente-di-prova.pdf

Paziente: Paziente di prova Compilato il: 27/09/2026

ACL-RSI, punteggio **51,7**

0 ← risposta meno favorevole risposta più favorevole → 100

Come leggere il risultato

Punteggio 51,7 su 100: più è alto, più favorevole è la risposta psicologica al ritorno allo sport (fiducia, emozioni, valutazione del rischio). Punteggio = media dei 12 item.

Validazione italiana: ICC 0,916; α di Cronbach 0,953. La versione italiana non indica un cut-off [1].

► Riferimento della letteratura, non validato in italiano

► Risposte item per item

1. Thiebat G, Cucchi D, Spreafico A, et al. Italian version of the anterior cruciate ligament-return to sport after injury scale (IT ACL-RSI): translation, cross-cultural adaptation, validation and ability to predict the return to sport at medium-term follow-up in a population of sport patients. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc* 2021. doi:10.1007/s00167-021-06498-8

2. Ardern CL, Taylor NF, Feller JA, Whitehead TS, Webster KE. Psychological responses matter in returning to preinjury level of sport after anterior cruciate ligament reconstruction surgery. *Am J Sports Med* 2013;41(7):1549-58. doi:10.1177/0363546513489284

Correggi risposte Rimuovi

Figura 3 – Esempio di risultato (ACL-RSI, paziente di prova).

3. Come leggere grafici e soglie

- **Barra verde:** punteggio del paziente nel range del questionario; sotto la barra è indicato il significato dei valori bassi e alti.

- **Linea verde scuro continua:** soglia indicata nella versione italiana (es. ÖMPQ-21: 105 e 130).
- **Linea arancio tratteggiata** e riquadro arancio «**non validato in italiano**»: soglie di altre versioni (es. PCS ≥ 30 , ACL-RSI < 56 , CSI ≥ 40 , yellow flags OSPRO-YF); vanno usate solo come informazione aggiuntiva.
- **MDC/SDC:** minima differenza tra due compilazioni che indica un cambiamento reale e non un errore di misura.

4. Questionari disponibili

Questionario	Area	Cosa misura	Min.
ODI-I	lombare	disabilità	≈ 5
OSPRO-YF 10	lombare	psicosociale, rischio	≈ 3
OSPRO-YF 17	lombare	psicosociale, rischio	≈ 5
OSPRO-YF 7	lombare	psicosociale, rischio	≈ 2
RMDQ-I	lombare	disabilità	≈ 5
STarT Back-IT	lombare	rischio, psicosociale	≈ 2
TSK-I	lombare	psicosociale	≈ 5
ÖMPQ-10	lombare	rischio, psicosociale	≈ 5
ÖMPQ-21	lombare	rischio, psicosociale	≈ 10
NDI-I	cervicale	disabilità	≈ 5
DASH-I	spalla	disabilità, sintomi	≈ 10
QuickDASH-I	spalla	disabilità, sintomi	≈ 3
SPADI (<i>provvisorio</i>)	spalla	dolore, disabilità	≈ 5
HAGOS-I	anca e inguine	sintomi, dolore, funzione, sport, qualità di vita	≈ 10
LEFS-I	anca e inguine	funzione	≈ 5
ACL-RSI	ginocchio	sport, psicosociale	≈ 2
IKDC	ginocchio	sintomi, funzione, sport	≈ 10
KOOS-I	ginocchio	sintomi, dolore, funzione, sport, qualità di vita	≈ 10
WOMAC	ginocchio	dolore, funzione, sintomi	≈ 10
VISA-A-I	caviglia e piede	sintomi, funzione, sport	≈ 5
CSI-I	generico	psicosociale, sensibilizzazione centrale	≈ 10
MSK-HQ (<i>provvisorio</i>)	generico	funzione, sintomi, qualità di vita	≈ 5
PCS-I	generico	psicosociale	≈ 5
PSEQ-I	generico	psicosociale	≈ 3
QUID	generico	dolore	≈ 5
SF-36	generico	qualità di vita, funzione	≈ 10

Versioni provvisorie (SPADI, MSK-HQ): il testo proviene da moduli non verificabili sulla validazione italiana; l'app lo segnala nel modulo e nel referto. **Attenzione anche a:** VISA-A italiano (10 domande, diverso dall'originale a 8), WOMAC (formato Likert; la validazione italiana ha usato la scala visiva), SF-36 (8 scale, senza indici PCS/MCS), QuickDASH (traduzione ufficiale IWH senza validazione italiana dedicata).

5. Domande frequenti

- **L'app non legge le risposte.** Usare **Chrome** (con Safari la lettura può non funzionare) e ricaricare la pagina. Verificare che il PDF sia stato **salvato** dopo la compilazione e non «stampato in PDF» (in quel caso i campi spariscono: usare «Inserisci risposte»).
- **Il paziente ha spuntato due risposte nello stesso item.** L'app non le considera e lo segnala: correggere con «Correggi risposte».
- **Mancano alcune risposte.** Ogni questionario segue le regole della propria validazione o degli sviluppatori: se sono troppe, il punteggio non viene calcolato e l'app spiega perché.
- **Posso usare l'app per pazienti minorenni?** Le validazioni italiane sono state condotte quasi sempre su adulti: la scheda del catalogo indica l'età del campione; interpretare con cautela.
- **Licenze.** Gli strumenti sono destinati all'uso clinico interno e non commerciale; alcune scale (es. DASH, QuickDASH, WOMAC, SF-36) hanno condizioni d'uso proprie. I moduli non vanno modificati né venduti.

Il risultato va sempre interpretato dal professionista insieme alla valutazione clinica.